

CASO SOCRÁTICO: DESMIELINIZANTES DEL SNC (GUÍA
DOCENTE)

CLAVES DOCENTES

Docente: Dr. Alcy Torres | Semestre 2026-2 | Semana 14 | Marco: KNOW → REASON → ACT

Viñeta Clínica de Entrada

- Paciente:** Femenina de 27 años, diseñadora gráfica, diestra, sin antecedentes patológicos previos.
- Motivo de consulta:** «Desde hace 5 días siento las piernas dormidas desde el ombligo hacia abajo y, cuando agacho el cuello, me baja una corriente por la espalda.»
- **Enfermedad actual:** Parestesias ascendentes en MMII en 48 h; estables hace 3 días. Urgencia miccional sin incontinencia. Afebril, sin foco infeccioso previo.
 - **Signo referido:** Sensación eléctrica en el raquis al flexionar el cuello (Lhermitte).
 - **Antecedente clave:** Hace **14 meses** tuvo visión borrosa en **ojo derecho** con dolor retroocular a la movilización durante 3 semanas. Remitió espontáneamente.
 - **Otros:** Fatiga crónica. Al ducharse con agua muy caliente nota que la visión de OD se «empaña» unos minutos (Uhthoff).

Examen Físico y Neurológico Dirigido

Vía Visual	AV: OD 20/30, OI 20/20. Desaturación al rojo en OD. Linterna oscilante: DPAR (Pupila de Marcus Gunn) en OD. Fondo de ojo: Palidez temporal del disco óptico en OD. OI normal.
Motilidad Ocular	Mirada hacia la izquierda: limitación de aducción en OD + nistagmo disociado en abducción en OI (Oftalmoplejía internuclear derecha por lesión del FLM). Convergencia conservada.
Motor y Reflejos	Fuerza 5/5 MMSS; 4+/5 flexores cadera/rodilla. Reflejos osteotendinosos: rotulianos y aquíleos 3/4; Babinski bilateral presente.
Sensibilidad	Hipoestesia táctil y dolorosa con nivel sensitivo T10 incompleto. Palestesia disminuida en maléolos. Signo de Lhermitte positivo.
Estudios Paraclínicos	RM Encéfalo: 6 lesiones T2 (3 periventriculares/Dawson, 1 yuxtacortical, 1 pedúnculo cerebeloso medio). <i>Sin realce.</i> RM Médula: Lesión T2 posterolateral T8-T9 (< 1 segmento) con realce intenso con Gd. LCR: 6 linfocitos, proteínas 42 mg/dL, Bandas Oligoclonales tipo 2 (+). CBA Inmuno: AQP4-IgG y MOG-IgG negativos.

GUÍA SOCRÁTICA CON CLAVES DE FACILITACIÓN DOCENTE

● ETAPA 1 — KNOW: IDENTIFICACIÓN Y TOPOGRAFÍA DEL EVENTO ACTUAL

1. ¿Cumple este episodio la definición operativa de brote? Cite 3 argumentos del caso.

Clave docente: Sí cumple. 1) Duración ≥ 24 h (lleva 5 días); 2) Se instaló de forma subaguda (48 h); 3) Paciente afebril y sin infección activa (descarta pseudobrote); 4) Déficit neurológico focal objetivo (nivel T10, Babinski).

2. Diagnóstico topográfico: ¿Dónde radica la lesión actual? ¿Qué sustrato tiene el signo de Lhermitte?

Clave docente: Mielopatía torácica focal parcial (cordones laterales y posteriores a nivel T8-T10). El *Signo de Lhermitte* traduce desmielinización en los cordones posteriores cervicales con hiperexcitabilidad mecánica de los axones sensitivos al estirar la duramadre.

3. Visión empañada con agua caliente: ¿Qué fenómeno es y por qué no es un nuevo brote?

Clave docente: Fenómeno de Uhthoff. Bloqueo fisiológico reversible de la conducción en axones previamente desmielinizados por elevación térmica mínima. Cede al enfriarse; *no traduce inflamación activa ni nuevo daño estructural*. No se trata con corticoides.

● ETAPA 2 — REASON: RECONSTRUCCIÓN LONGITUDINAL Y HALLAZGOS SUBCLÍNICOS

4. ¿Qué datos del examen físico prueban objetivamente la secuela de la neuritis óptica previa?

Clave docente: 1) **DPAR en OD** (pupila de Marcus Gunn: dilatación paradójica en la linterna oscilante por defecto de conducción aferente); 2) **Palidez temporal del disco óptico en OD** (atrofia de las fibras del haz papilomacular); 3) **Desaturación al rojo en OD**.

5. ¿Qué alteración presenta la motilidad ocular conjugada y qué aporta a la localización?

Clave docente: Oftalmoplejía Internuclear (OIN) derecha por lesión del Fascículo Longitudinal Medial (FLM) derecho en el tronco encefálico (puente/mesencéfalo). Agrega una tercera localización topográfica clínica independiente (tronco encefálico).

6. Con la clínica y examen solamente, ¿hay evidencia de DIT y DIS?

Clave docente: Sí, clínicamente demostrada. DIS: nervio óptico + médula torácica + cordón posterior cervical + tronco encefálico (FLM). DIT: neuritis óptica resuelta hace 14 meses y mielitis activa hace 5 días (separados por > 30 días).

● ETAPA 3 — REASON: CRITERIOS MCDONALD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CRÍTICO

7. Aplique McDonald 2017 a la RM: ¿Qué regiones cumplen DIS? ¿Cómo se demuestra DIT en una sola RM?

Clave docente: DIS: Cumple 4 de 4 regiones canónicas (periventricular [Dawson], yuxtacortical, infratentorial [pedúnculo] y médula). Se exigen ≥ 2 .

DIT: Presencia *simultánea* de una lesión asintomática/sintomática que capta gadolinio (médula T8-T9) junto con lesiones que no captan gadolinio (encefálicas).

8. Valor de las bandas oligoclonales si la RM ya demostraba DIS y DIT:

Clave docente: 1) Confirman síntesis intratecal de IgG (respaldo diagnóstico de alta especificidad); 2) Descartan diagnósticos miméticos; 3) En casos donde falta DIT por imagen, las BOC sustituyen el criterio de DIT según McDonald 2017.

9. EL GIRO CRÍTICO: Si la mielitis fuera continua T3-T8 (LETM) y la neuritis grave bilateral:

Clave docente: Trastorno del espectro de Neuromielitis Óptica (NMOSD). Solicitar AQP4-IgG. **PELIGRO CLÍNICO:** Están formalmente **contraindicados fármacos modificadores de EM** (interferón beta, fingolimod, natalizumab), ya que pueden desencadenar brotes catastróficos o estado de mal miélico.

● ETAPA 4 — ACT: CONDUCTA EN LA GUARDIA Y PLAN AL ALTA

10. Tratamiento del brote agudo (fármaco, dosis y expectativa real explicada al paciente):

Clave docente: Metilprednisolona IV 1 g/día en infusión durante 3 a 5 días consecutivos con protección gástrica. Se explica con claridad que *acelera la velocidad de recuperación funcional* del episodio actual, pero *no cambia la discapacidad acumulada ni el pronóstico a largo plazo*.

11. Educación preventiva ante fiebre o calor (evitar error de corticoides en pseudobrote):

Clave docente: Se educa en que ante un aumento de temperatura corporal (infección, ejercicio, calor) los síntomas antiguos pueden reaparecer transitoriamente. Debe tratarse la causa de base (antipiréticos, tratar foco urinario). No requiere corticoides ni traduce avance de la enfermedad.

12. Plan de transición al alta (3 acciones con Neurología):

Clave docente: 1) Derivación inmediata a consulta de neuroinmunología para inicio de Terapia Modificadora de la Enfermedad (TME); 2) Evaluación basal de discapacidad (escala EDSS); 3) Tamizaje pre-inmunosupresión (serologías infecciosas: VHB, VHC, VIH, tuberculosis latente, anticuerpos anti-JC virus) y actualización del esquema de vacunas.